O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-5: Ko‘z gavhari va shishasimon tana kasalliklarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda katarakta bilan og‘rigan bemorlarni davolash uchun tomchi dorilarga retseptni o‘qish va yozishda ishtirok etish, bemorni operatsiyaga tayyorlash, operatsiyadan keyingi bog‘lam qo‘yish, ko‘zga dori tomizish, ovqatlantirish va parvarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Kataraktaning boshlang‘ich davrida davolash va tomchi dorilarga retsept
2. Kataraktaning turli davrlarida bemorni operatsiyaga tayyorlash
3. Operatsiyadan keyingi davrda bog‘lam qo‘yish, dori tomizish, ovqatlantirish va parvarish

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Boshlang‘ich kataraktada buyuriladigan tomchilar retseptini o‘qiydi va yozishda ishtirok etadi.
- Bemorni operatsiyaga tayyorlash bosqichlarini bajaradi.
- Operatsiyadan keyingi davrda ko‘zga bog‘lam qo‘yadi va dori tomizadi.
- Operatsiyadan so‘ng bemorni ovqatlantirish va parvarish qilish qoidalarini biladi.

Tayanch so‘zlar

retsept, Rp., D. S., taufon, operatsiyaga tayyorlash, binokulyar bog‘lam, operatsiyadan keyingi parvarish, premedikatsiya.

1. Kataraktaning boshlang‘ich davrida davolash va tomchi dorilarga retsept

Katarakta boshlang‘ich bosqichda bemorga jiddiy noqulaylik keltirmasligi mumkin. Shifokor bu davrda kuzatuvni va metabolik tomchilarni buyuradi. Ularning vazifasi gavhardagi modda almashinuvini yaxshilash va xiralashish rivojlanishini sekinlashtirish. Tomchilar xiralashgan gavharni tiniq qilmaydi, shuning uchun hamshira bemorga bu haqda rost ma’lumot beradi va u operatsiyadan voz kechmasligi kerakligini tushuntiradi. Asosiy maqsad bor ko‘rishni saqlab qolish, muntazam tekshiruvdan o‘tib turish va operatsiya vaqtini to‘g‘ri belgilash. Tomchilar uzoq muddat, kurslar bilan tomiziladi.

Retsept shifokor yozadigan rasmiy hujjat bo‘lib, hamshira uni o‘qiy olishi, bemorga tushuntirishi va to‘g‘ri bajarishi kerak. Retsept lotin tilida yoziladi, shuning uchun asosiy qisqartmalarni bilish talab etiladi.

Qisqartma	To‘liq shakli	Ma’nosi
Rp.	Recipe	Ol
Sol.	Solutio	Eritma
Ung.	Unguentum	Malham
Oculent.	Oculentum	Ko‘z malhami
D. S.	Da. Signa	Ber. Belgila (ishlatish tartibi)
D. t. d.	Da tales doses	Shunday miqdorda ber
N.	Numero	Soni

Retsept namunalari

Tomchi dorilar uchun retseptda eritma nomi, foizi va hajmi, keyin ishlatish tartibi yoziladi. Masalan: Rp.: Sol. Taurini 4% – 10 ml. D. S. Ko‘zga 2 tomchidan kuniga 3 mahal tomizilsin. Bu yozuv quyidagini bildiradi: 4 foizli taurin eritmasidan 10 ml oling, bemorga bering, har bir ko‘zga kuniga 3 marta 2 tomchidan tomizilsin. Yana bir misol: Rp.: Sol. Sulfacyli-natrii 20% – 10 ml. D. S. Ko‘zga 1–2 tomchidan kuniga 4 mahal tomizilsin. Retseptda bemor familiyasi, yoshi, sana, shifokor imzosi va muhri bo‘lishi shart.

Retsept bilan ishlash tartibi

Jihozlar: retsept, dori, bemor varaqasi

1. Retseptdagi bemor ma’lumotini tekshiring.
2. Dori nomi, foizi va hajmini aniqlang.
3. Ishlatish tartibini o‘qing: necha tomchi, necha marta, qaysi ko‘zga.
4. Dorining yaroqlilik muddatini tekshiring.
5. Bemorga o‘z tilida tushuntiring: vaqt, soni, tomchilar orasidagi tanaffus.
6. Tomizishni namoyish qiling va bemorga takrorlatib ko‘ring.
7. Tomchi jadvalini katta harflar bilan yozib bering.

Bemorga beriladigan tavsiyalar

Hamshira boshlang‘ich kataraktali bemorga tomchilarni muntazam tomizish, quyosh nuridan himoya ko‘zoynagi taqish, chekmaslik, vitaminlarga boy ovqatlanish, qandli diabet bo‘lsa, qandni nazorat qilish va har 6 oyda shifokor ko‘rigidan o‘tish zarurligini tushuntiradi. Ko‘rishi pasaygan bemor mashina haydashi yoki baland joyda ishlashi xavfli ekani aytiladi. Keksa bemorlar uchun uyda yiqilishning oldini olish muhim: xona yaxshi yoritilishi, gilamlar mahkamlanishi va zinada tutqich bo‘lishi kerak. Bemor ko‘rishi yomonlashsa, kechiktirmasdan kelishi lozim.



Katarakta: chap ko‘zda qorachiq sohasi kulrang-oq

Tomchilarni saqlash ham tushuntiriladi: ochilgan flakon odatda bir oy ichida ishlatiladi, sovuqda yoki qorong‘i joyda saqlanishi kerak bo‘lsa, bu retseptda yoki yo‘riqnomada aytiladi. Dori flakoni uchi ko‘z va kipriklarga tegmasligi kerak, tomchi tomizilganda ichki burchak 1–2 daqiqa bosib turiladi. Bir nechta dori buyurilgan bo‘lsa, ular orasida kamida 5 daqiqa tanaffus qilinadi. Bemorning yaqinlari ham tomizish qoidalariga o‘rgatiladi.

2. Kataraktaning turli davrlarida bemorni operatsiyaga tayyorlash

Operatsiyaga to‘g‘ri tayyorgarlik uning muvaffaqiyati va asoratlar oldini olishning asosiy shartidir. Ambulator bosqichda bemorni shifokor tekshiradi: ko‘rish o‘tkirligi, ko‘z ichi bosimi, ko‘z tubi, biometriya, shuningdek, umumiy tahlillar, qon qandi, EKG, terapevt, stomatolog va LOR ko‘rigi. Organizmda infeksiya o‘choqlari (kariyes, tonzillit, sinusit, dakriotsistit, blefarit, kon’yunktivit) bo‘lsa, ular avval davolanadi, chunki infeksiya ko‘z ichiga tushib, endoftalmitga olib kelishi mumkin. Qon bosimi va qon qandi barqaror bo‘lishi kerak.

Operatsiyadan oldingi kun

Hamshira bemorga operatsiyaning maqsadi va tartibini tushuntiradi, savollariga javob beradi, qo‘rquvini kamaytiradi. Bemorga qon suyultiruvchi dorilar haqida so‘raladi va bu haqda shifokorga ma’lum qilinadi. Bemor iliq suvda yuvinadi, tirnoqlari olinadi, ichki kiyim va o‘rin-ko‘rpa jildlari almashtiriladi. Erkaklarga soqol olish tavsiya etiladi, ayollar kosmetikadan foydalanmaydi. Kechqurun shifokor ko‘rsatmasi bilan tinchlantiruvchi dori beriladi. Kechqurun

yengil ovqat yeyiladi, operatsiya och qoringa qilinishi rejalashtirilsa, bu qoidaga amal qilinadi. Bemorga ich yurishi tartibga solinadi.

Bemorni operatsiyaga tayyorlash

Jihozlar: toza oqliklar, steril qaychi (kerak bo‘lsa), antiseptik, buyurilgan tomchilar, paxta, ro‘mol

1. Bemorning hujjatlari, tahlillari va operatsiya ko‘zini tekshiring.
2. Bemor vannada yuvinadi, oqliklari almashtiriladi.
3. Shifokor ko‘rsatmasi bilan operatsiya bo‘ladigan ko‘zning kipriklari qisqartiriladi.
4. Kon’yunktiva bo‘shlig‘i antiseptik eritma bilan yuviladi.
5. Belgilangan vaqtda antibiotik va qorachiqni kengaytiruvchi tomchilar tomiziladi.
6. Operatsiyadan 30 daqiqa oldin shifokor belgilagan premedikatsiya bajariladi.
7. Bemor boshiga ro‘mol yoki qalpoq kiydiriladi, operatsiya tomonidagi qulog‘iga paxta qo‘yiladi.
8. Bemor aravachada operatsiya xonasiga kuzatib boriladi.

Kataraktaning davriga qarab e’tibor

Yetilmagan kataraktada bemor hali ko‘ra oladi, shuning uchun u oddiy tayyorgarlikdan o‘tadi. Yetilgan kataraktada ko‘rish juda past bo‘lgani uchun bemorga yurishda yordam beriladi, xavfsizlik ta’minlanadi. O‘ta yetilgan kataraktada ko‘z ichi bosimi oshishi va yallig‘lanish xavfi bor, shuning uchun bemor kuzatuvda bo‘ladi, ko‘z ichi bosimi tez-tez o‘lchanadi va operatsiya kechiktirilmaydi. Qandli diabetli bemorda qand operatsiya kuni ham nazorat qilinadi, ovqatlanish va gipoglikemiya xavfi hisobga olinadi. Keksa bemorlarda yurak dorilari qabul qilish tartibi shifokor bilan kelishiladi.

Hujjatlar va xavfsizlik

Operatsiyadan oldin bemor yoki uning vakili rozilik varaqasini imzolaydi. Hamshira operatsiya qaysi ko‘zda bo‘lishini hujjatlardan tekshiradi, chunki ko‘zni adashtirish og‘ir xatodir. Bemorda protezlar, taqinchoqlar, ko‘zoynak va kontakt linzalar yechiladi. Operatsiya oldidan bemor siydik pufagini bo‘shatadi. Hamshira bemorning umumiy holati, tana harorati, puls va qon bosimini o‘lchab qayd etadi. Isitma, shamollash, kon’yunktivit belgilari aniqlansa, darhol shifokorga xabar beradi, operatsiya vaqti ko‘rib chiqiladi.



Operatsiyadan keyin bemorni ehtiyotkorlik bilan tashish

Operatsiyadan oldin bemor tomchilarni tomizish tartibini bilishi uchun hamshira uni oldindan o‘rgatadi. Bemorning ko‘zoynagi, tish protezi va dori-

darmonlari belgilab, xavfsiz joyda saqlanadi. Tashvishli bemorlarga oldin operatsiya qilingan bemor bilan suhbatlashish imkoni berilishi foydali. Qandli diabetli bemorlarda insulin dozasi shifokor bilan oldindan kelishiladi.

Tayyorgarlik yakunida hamshira bajarilgan barcha muolajalarni operatsiya oldi varaqasiga belgilaydi.

3. Operatsiyadan keyingi davrda bog‘lam qo‘yish, dori tomizish, ovqatlantirish va parvarish

Operatsiyadan keyingi davr ko‘z tiklanishi uchun juda muhim. Bemor operatsiya xonasidan aravachada olib chiqiladi va ehtiyotkorlik bilan o‘ringa yotqiziladi. U shifokor ko‘rsatmasiga ko‘ra birinchi soatlarda chalqancha yoki sog‘lom tomonga yotadi. Zamonaviy fakoemulsifikatsiyadan keyin tartib ancha yengil, bemor bir necha soatdan so‘ng turishi mumkin; an’anaviy operatsiyalardan keyin esa 1 kun yotoq tartibi buyuriladi. Hamshira bemor holatini, bog‘lamni, og‘riqni, tana harorati va qon bosimini kuzatadi.

Bog‘lam qo‘yish

Operatsiyadan keyin ko‘zga steril bog‘lam qo‘yiladi. Binokulyar bog‘lam ikkala ko‘zga qo‘yilib, ko‘z harakatini kamaytiradi va tinchlik yaratadi. Bog‘lam qattiq tortilmaydi, bint bilan quloq solinchog‘i orasiga barmoq sig‘ishi kerak. Bog‘lam ifloslansa yoki nam bo‘lsa, almashtiriladi, ammo uni shifokor ko‘rsatmasisiz butunlay olib tashlamaydi.

Binokulyar bog‘lam qo‘yish

Jihozlar: steril bint, doka yostiqchalar (9×10 sm), leykoplastir, steril qaychi, steril qo‘lqop

1. Qo‘lni yuving, qo‘lqop kiying, bemorga tushuntiring.
2. Ikki ko‘zga steril doka yostiqcha qo‘ying.
3. Bintni peshona va ensa atrofidan 2 marta aylantirib mahkamlang.
4. Bintni ensa orqali quloq ostidan o‘ng ko‘zga, undan peshona orqali ensaga olib o‘ting.
5. Peshonadan ikkinchi ko‘zga, quloq ostidan ensaga o‘tkazing.
6. Ko‘zlar batamom yopilguncha o‘ramlarni navbatlang.
7. Oxirini mahkamlang: bog‘lam qattiq bo‘lmasin, barmoq sig‘sin, quloqlar ochiq tursin.

Ko‘zga dori tomizish

Bog‘lam olingandan keyin shifokor belgilagan antibiotik va yallig‘lanishga qarshi tomchilar tomiziladi. Qo‘l yuviladi, qo‘lqop kiyiladi, ko‘zga bosim berilmaydi: pastki qovoq yonoq sohasidan yengil tortiladi, yuqori qovoq ko‘tarilmaydi. Pipetka va flakon uchi ko‘zga tegmaydi. Kipriklardagi ajralma steril tampon bilan ichki burchakdan tashqiga tozalanadi. Har bir bemorga alohida steril tomchi ishlatiladi.

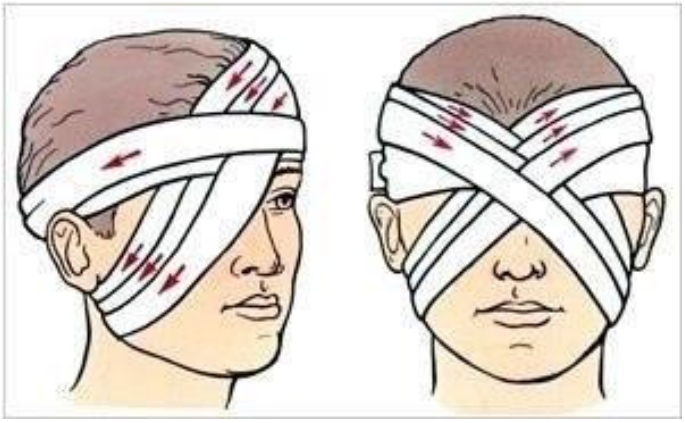
Ovqatlantirish va parvarish

Birinchi kuni bemor hamshira yordamida ovqatlanadi: suyuqlik suvdondan ichiriladi, ovqat qoshiqda beriladi. Oziq-ovqat yumshoq, yengil hazm bo‘ladigan va issiq bo‘lmasligi kerak, qattiq chaynaladigan taomlar berilmaydi. Ich qotishining oldini olish uchun tolali mahsulotlar va suyuqlik tavsiya qilinadi, kuchanish man etiladi. Ko‘ngil aynisa, bemor yonboshiga o‘giriladi. Yo‘tal va aksirishga qarshi choralar ko‘riladi, chunki ular ko‘z ichi bosimini oshiradi. Bemorga og‘ir yuk ko‘tarish, engashish, keskin harakat, ko‘zni ishqalash man etilgani tushuntiriladi.

Asorat	Belgilari	Hamshira harakati
Qon ketishi	Bog‘lam qonashi, og‘riq	Darhol shifokorga xabar
Ko‘z ichi bosimi oshishi	Kuchli og‘riq, ko‘ngil aynishi	Shifokorga xabar, bosim nazorati
Infeksiya (endoftalmit)	Og‘riq, qizarish, ko‘rish pasayishi	Shoshilinch shifokor ko‘rigi
Kesimdan suyuqlik oqishi	Yosh oqishi, ko‘z yumshoq	Bog‘lam, shifokorga xabar

Uyga chiqarish

Bemorga yozma tavsiya beriladi: tomchilar jadvali, himoya ko‘zoynagi taqish, yuvinganda ko‘zga suv kirmasligi, sovun tegmasligi, changli joylardan saqlanish, 1 oy davomida og‘ir ish qilmaslik va belgilangan kunlarda kuzatuvga kelish. Ko‘zga issiq sauna va basseyn man etiladi. Ko‘rish keskin pasayishi yoki og‘riq kuchayishi zudlik bilan murojaat qilish uchun asosdir. Sun’iy gavhar o‘rnatilgan bemorda keyinchalik yaqin yoki uzoq uchun ko‘zoynak kerak bo‘lishi mumkin, u odatda 1–2 oydan so‘ng tanlanadi.



Monokulyar va binokulyar bog‘lamlar

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.

4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.